PM&R PGY Survival Guide

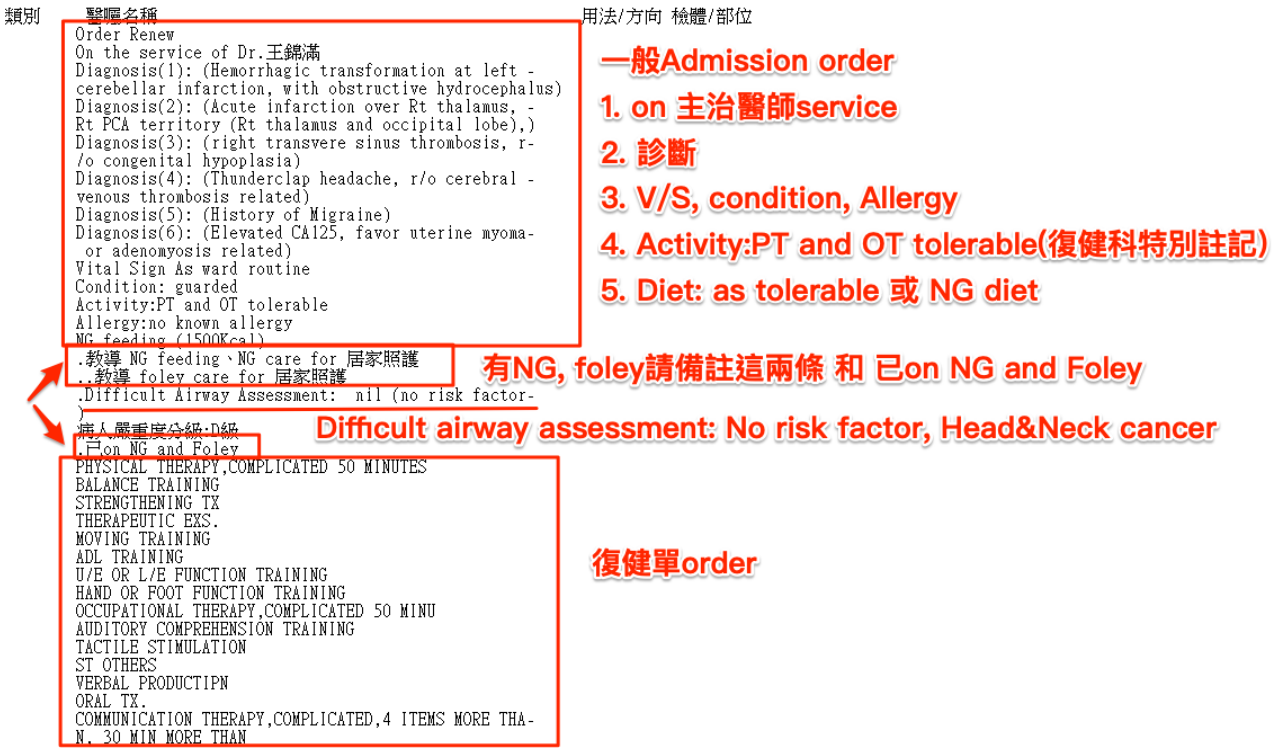
接 New patient

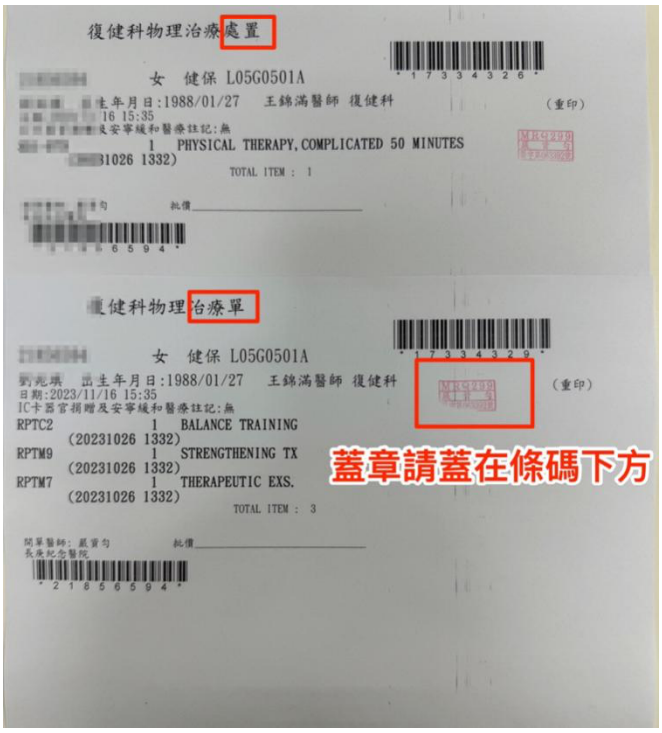
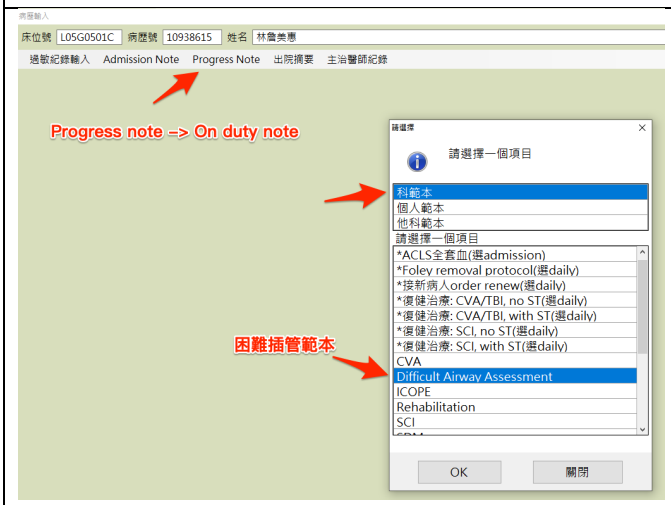
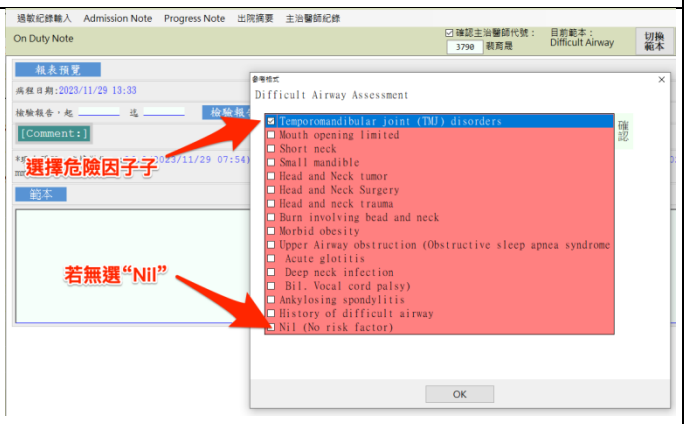
1. 他科轉入(最常見)

   - Order 範本(Order Renew) + 復健 order 單(**大部分不用開復健卡片，開什麼項目請參考第一次復健會診之內容**) + Acceptance note + On duty note (困難插管評估)
   - Acceptance 請參考會診學長姐會診內容 + 自己評估 + update 轉下來前發生的狀況
   - On duty note：科範本->Difficulty Airway Assessment->選擇危險因子->**點確認**->**再按 OK 帶入**->存檔
   - 若病人具有困難插管風險->需要開立 order：JOD382

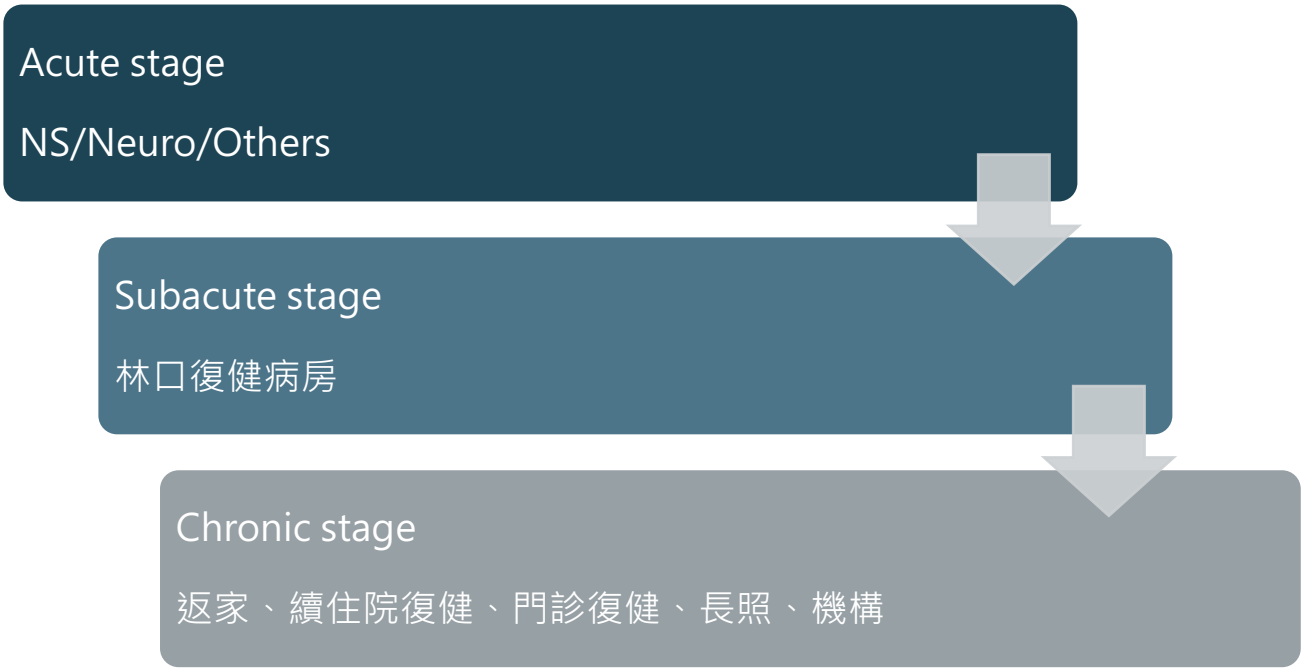
2. 門診

   - Admission Order + 復健單(「**要」開復健卡片**) + Admission note + On duty note

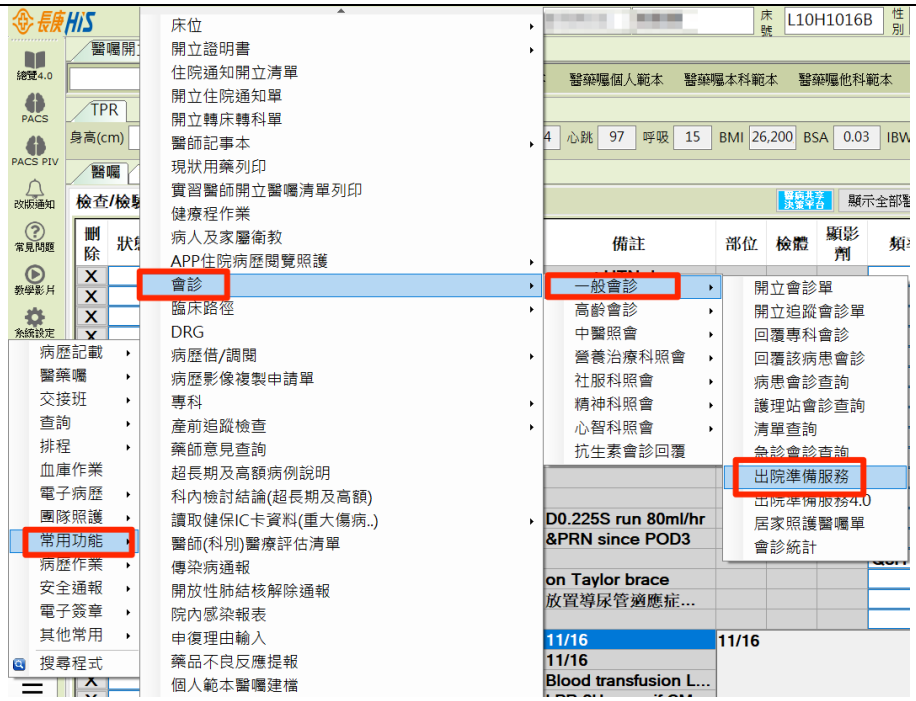


復健 order 單	復健卡：開卡請找 R1/CR 協助
單子蓋章 (蓋在條碼下面) 後請直接拿給 5H 復健櫃台姊姊，避免護理師多跑一趟  	
On duty note: Difficult airway assessment 困難插管   	

出院



1. 盡量「今辦明出」或「今辦明結」(如果有管路)
2. ****住在 6H 的病人，要開立出院 order 前請一律先通知 CR**
3. 可住時間：轉入復健科算起抓 28 天（動態調整），**但「入住長庚醫院」起的總住院天數不超過 60 天**，病人要出院/預定出院請不定時在群組回報
4. 出院動向討論：建議於病人到復健科的第一週內，先口頭告知「出院時間以主治醫師與復健團隊觀察為準」，本次於復健病房預計可住到何時，之後在出院前約 2～3 週時，開始討論出院動向
5. 所有出院病人**若有出院困難一律會診「出院準備服務」**，請轉介護理師協助討論動向
6. 出院方向：(1)回家 (建議同時詢問是否需要協助做長照評估申請，若要評估至少出院三個工作天前需會診)、(2)桃園長庚、(3)基隆長庚、(4)其他醫院名單 (5)照護機構/護理之家。有問體可與病房總醫師討論，也可照會轉介護理師討論

開立出院準備服務： 常用功能 →會診→一般會診→出院準備服務→勾選對應項目→存檔 **醫囑：** 重新點入該病人醫囑系統，會自動帶入 **“.consult discharge planing”** ，請記得再儲存送出 order	

7. 轉桃園長庚：若病人臨床狀況穩定可與病人及家屬討論後，告知主治醫師，並開立桃分住院單。若病人狀況相對不穩定或有任何事項需要特別交班，請先與病房 CR 討論。與主治討論後，確定可轉桃分的病人，請開立桃分住院單及 Order「開立住院通知單」，**並於Order 備註寫「已開立桃園長庚住院通知單 (since 2025/xx/xx)」**

8. 住院通知單日期非實際轉床日期，要轉桃分前一天 CR 會詢問 primary 是否穩定與家屬同意轉→CR 跟桃分要床→等病房書記通知桃分有床才開出院 order。

9. 轉土城、基隆長庚：皆先來找病房 CR 詢問後再行動

10. 其他醫院：**請病人家屬「自行」拿病歷摘要去有「住院復健」的醫院復健科門診「自費」掛號**，由他院主治醫師評估可否收治、排床。台灣各地區有住院復健的醫院名單，可會診出院轉介護理師詢問，還有協助與家屬討論。當家屬告知外院通知有床時，確定轉院日期後，再開立出院醫囑。因病人至外院住院，於本院視為一般出院，請協助約一週內的門診，藥量開足至回診，再告知家屬若順利住進外院病房後，可自行取消門診。

11. 以下為不同出院動向須完成的臨床業務：

動向	是否需照會出準	準備文件
回家	X（一般人） O（需要長照、有管路者）	出院 order (一般) 出院藥物 約回診 (復健科 + 其他科) PRN 診斷書

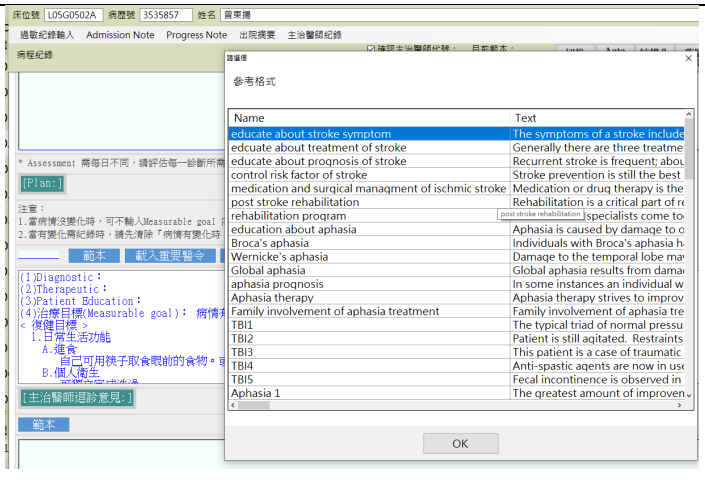
		PRN 病歷摘要
桃分	X	出院 order (出院狀況：轉院) 出院帶藥 **1 天** 約回診 (復健科 + 其他科) PRN 診斷書 PRN 病歷摘要 一般轉診單（會印出 5 張紙，蓋章） 在 team+群組 Tag 桃分 CR 交班
情人湖(基隆)	X	出院 order (出院狀況：轉院) 出院帶藥 **1 天** 約回診 (復健科 + 其他科) PRN 診斷書 PRN 病歷摘要 一般轉診單
其他如外院、護理之家、長照...	O （尤其是出院動向困難者）	出院 order (一般) 出院藥物 約回診 (復健科 + 其他科) PRN 診斷書 PRN 病歷摘要

病歷注意事項

- Acceptance note：course and treatment 需要包含前面住院的病歷(e.g. 神內、神外)，需將條列式病歷**改為敘述式病歷**，並包含復健評估、PE、NE
- Progress note：每日於 objective 需輸入不同評估

W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
復健評估	PE	Barthel index	復健紀錄 (PT/OT/ST)	復健評估 +PE+NE	改 S 復健評估	由本科 R/VS 完成
VS comment	Teaching	VS comment	Teaching	VS comment		

- 星期六病歷，值班醫師以「自己的帳號」完成「5G 病房」住院病人的 Progress note，將 S 的部分統一改為「 Activities of daily living impairment」，若當日有病人出院，請於出院前完成病歷，以避免後續被病歷課及主治醫師追殺
- 星期日值班不需寫病歷
- Measurable goal：善用「科範本」。病歷輸入 → progress note → 點選『科範本 +Rehabilitation 』→ Plan 點範本 → Measurable Goal (有下拉式選單)
- 主治醫師迴診意見：善用「科範本」。

Measurable Goal	主治醫師迴診意見
	

- 分段結清：住太久者需分段結帳，書記通常會提醒你。常用功能→搜尋：**分段結清病摘輸入(交付書記)**，點選正確時間的住院段落，完成病歷，存檔、列印，**印出來給書記**

- 出院病歷
  - 出院的主診斷請一定評估並寫上 modified Rankin scale (mRS)，要有功能性診斷，有排過 ST 的人不要漏掉 Dysphagia/aphasia/dysarthria
  - modified Rankin scale：或請參考 orientation ppt

Modified Rankin Scale

Score	Description
0	No symptoms at all
1	No significant disability despite symptoms; able to carry out all usual duties and activities
2	Slight disability; unable to carry out all previous activities, but able to look after own affairs without assistance
3	Moderate disability; requiring some help, but able to walk without assistance
4	Moderately severe disability; unable to walk without assistance and unable to attend to own bodily needs without assistance
5	Severe disability; bedridden, incontinent, and requiring constant nursing care and attention
6	Dead

  - 出院病歷中請在「出院狀況」中將 Barthel index 帶入
  - PE 部分**需更新至最新一次的 rehabilitation assessment**，以利後續病人於他院的復健治療計劃制定

- 病歷的 **Assessment 盡量不要寫縮寫**：一個完整的復健科診斷包含：臨床診斷, Onset, 經過哪些處置, 功能性診斷, 評估量表, 目前的後遺症, mRS，例如：

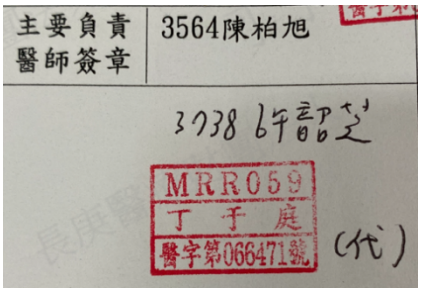
1. **腦中風**：Right thalamic hemorrhage, onset on 2019/01/02, with left hemiparesis, modified Rankin scale: 3
2. **創傷性腦傷**：Traumatic brain injury with right fronto-temporo-parietal subdural hemorrhage, onset on 2018/11/21, status post craniectomy on 2018/11/21, status post cranioplasty on 2019/02/19, Rancho Los Amigos level: IV, with left hemiplegia, dysphagia, modified Rankin scale: 4
3. **脊髓損傷**：Spinal cord injury, onset 2019/06/01, with C3-5 herniated intervertebral disc, C5-6 ruptured disc, spinal compression and myelopathy, status post C3-6 anterior discectomy and interbody fusion with PEEK cage on 2019/06/01, Neurologic level: C6, American Spinal Injury Association impairment scale: C, with the sequelae of tetraplegia

住院通單如何開立？ 桃分, 情人湖院區

路徑：常用功能→開立住院通知單，跳出視窗後請照下圖流程完成住院單



1. 特殊床位：改為「H.慢性床」
2. 簽住院區：5. 桃園長庚
3. 主治醫師：**一律輸入 ~~3564 陳柏旭~~** 8941吳致寬（3A）
4. 主診斷的 ICD-10 碼，可由「病歷記載→住院診斷修改」或者雙擊「DRG」欄位查詢 (常用診斷如：其他腦血管疾病：I6789, SCI/TBI：T07)
5. 預定住院日期：開單當天
6. 備註欄註記：**此住院單有效至 yyyy/mm/dd**（此為你開單當天的日期「再加上一個月」）
7. 是否為復健：是 / 功能障礙：選「重攤」，最後選「存檔列印」
8. 印出後，主要負責醫師簽章下方，**手寫：~~3738 許韶芝(5A)~~**，最後再蓋自己的方章，旁邊寫上「代」 8047 陳建宏（5A）



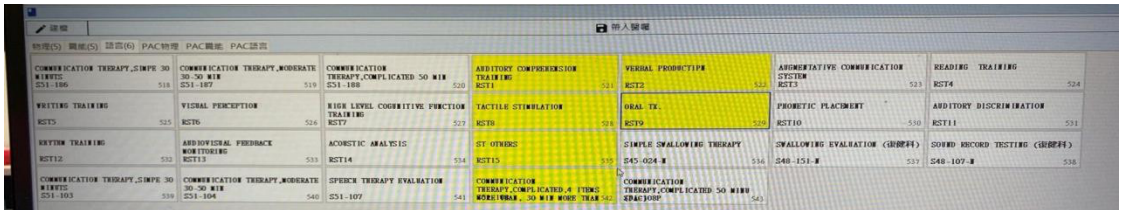
* 去基隆：請先問 CR 要簽給誰

復健單/復健卡怎麼開？（原則：問 CR/R1）

- 復健單(開復健 order 存檔後會自動印出)：建議皆用科範本來開立較為方便不易出錯。若要嘗試自行開立，請點選 HIS 右上方的工具箱中的復健治療，開立 PT/OT/ST：5/5/6 項的治療項目，詳見下方圖片。
- **非 Stroke or TBI 的病人開 ST 項目，請先找 CR 確認**
- 復健卡片：只有「門診新病人」或「他科轉入時卡片不見」的病人要開立，多數轉入的病人之前已由會診醫師開過復健卡片，只需重開復健單就好。**請幫忙檢查之前會診單有沒有開 ST**







值班

- **上下班時間：07:30-17:00**，接新病人則以 16:30 為界
- Day off：同 team PGY 負責 cover，請**確實交班，並主動告知護理站(寫在電子白板)**
- 值班二線請看班表，找當天值班 R2（代號：L1/EM，或至 6H 看電子白板一線寫誰)
- 值班時病人有狀況，一定要記得紀錄 On duty note，並且隔天口頭與當科交班
- 星期六值班：用自己的帳號打 Progress Note (**早點完成，免得病人出院沒寫到有主治醫師可能會生氣**), S 要改成 Activities of daily living impairment。
- 記得，保護自己&call for help，**不代為解釋重要或醫糾個案的病情**

其他

- 平日藥物若到期，若有**一個以上**藥物到期，請**九點半過使用 "Renew"** ，不要用 EXTN
- 請確認手上病人 DAPT 要用多久，標明在病歷以及藥物附註，Newpa 不確定請打給上游科
- 以下藥物，若有健保適應症才可健保使用 ；若無則以自費使用（若有自費請主動與病人或家屬解釋）：
  - Tamsulosin, Silodosin (女性需自費)
  - Celecoxib >50 歲、 Etoricoxib >60 歲 (健保)
  - Gabapentin, pregabalin (小寫我們開不出來、大寫 SCI, Neuropathic pain 健保)
  - PPI: 很確定有胃出血的臨床症狀健保可給付，若不確定可與主治醫師討論。多數病人仍須有 EGD report 確定有出血才可用健保身份使用藥物
  - Clopidogrel: 除非有 aspirin 過敏，不然都要自費
  - 痠痛藥膏 Etofenamate (rheuma gel 健保 1PC/月)
  - 貼布 Flurbiprofen (健保 1PC/週)
  - 補充：如果病人已有口服止痛藥了，貼布和藥膏都要自費。病人的痠痛藥膏為自費的話，貼布可每週以健保方式開立
- 診斷書：需要包含前端急診、急性病房日期、轉入復健科日期 ，印出前請找病房 CR 或 R1 看過
- 拔 NG 條件：(1) ST 評估吞嚥功能可，(2)可配水從嘴巴吃藥，(3)一天喝水量超過 1500 ml

- 拔 foley：與病房 CR 或主治醫師討論，請使用科範本: check residual urine 解尿後 once or if 六小時未解尿，if RU<150 ICP once, RU>300 re-on Foley。如果尿得順則，再測兩天 HS RU 才算過關
- Bisacodyl 請開 QN
- 新病人轉入病房若想要繼續中醫針灸，需發追蹤會診

易缺漏事務

- 假日出院的病人當天還是要有 progress note or Holiday note
- 病歷記載未完成：查詢病歷課的病歷未完成
- 出院病摘：巴氏量表未記錄、MRS 分數和 ADL 分數不相符
- **一些繁瑣規矩（主要是利於護理工作，若有不合理可與 CR 討論，請避免直接衝突）**
  - 請醫師盡量使用靠近護理站門口的 3 台電腦及小房間電腦
  - 檢查單、同意書、自費同意書開立後請夾 chart 並且放至護理站綠箱
  - VFSS (Videofluoroscopic Swallowing Study)需要檢查單跟同意書
  - 排完 VFSS 之後要再跟病患 ST 老師確認一下時間，可至護理站旁 ST room 找治療師
  - IV LASER 業務，請當科協助：（目前業務較少）
    a. 通知病患時間
    b. 做完 IV laser 後，檢查單請備註：治療日期、計價主治醫師
    c. 同時產生電子自費同意書
    d. 請將檢查單跟夾 chart，放護理站綠箱子
  - 抗生素藥物 vial/ ampule，盡量開立 IVD，e.g. Rocephin IV 仿單表示必須推 2-4 分鐘，開立時請改成 IVD 較方便護理同仁執行
  - Esomeprazole 開立 IVD，除非 VS 另有指示或是病患狀況特殊

常用 Order

Bladder Scan	**D918-090** BLADDER SONOGRAPHY FOR MEASUREMENT OF URINE AMOUNT (膀胱餘尿測量)	備註寫： >150ml ICP once，>300ml On Foley 請善用醫囑科範本
IV Laser	**S51-993** Intravascular Laser Irradiation	每次開單 自費同意書
rTMS	**M23-280-N** REPETIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION（復健科）	每次開單(次數 002) 費用$4000 ($2000/次) 自費同意書
吞嚥攝影 VFSS	**X75-980** Video Fluoroscopy	檢查單 檢查同意書
機器手	**S51-006** Robotic-assisted Occupational Therapy (Upper Limbs)	問病房 CR 每次開單 自費同意書 2500 元/次
尿路動力學 UDS	**S44-101** CYSTOMETROGRAPHT **S44-102** SPHINCTER E.M.G **S44-103** UROFLOW STUDY **S44-104** URETHRAL PRESSURE PROFILE(U.P.P)	請泌尿科做，檢查前需確認 UA 乾淨無感染，檢查結束 Foley 會直接 remove
軟組織超音波	**S46-202-N** SOFT TISSUE ECHO(復健科)	開好 order 請病房 CR 排程
肌電圖 NCV /EMG 上肢 *	**M29-036-N** NERVE CONDUCTION VELOCITY UPPER LIMBS (復健科) **M29-042-N** F WAVE (復健科) **M29-032-N** EMG HAND (復健科) **M29-046-N** SNCV, HAND (復健科)	請病房 CR 排程

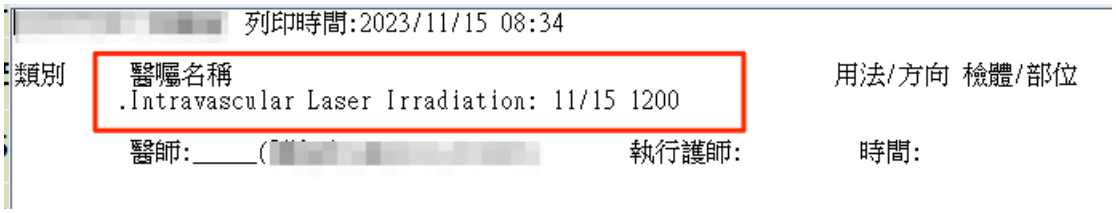
肌電圖 NCV /EMG 下肢 *	**M29-037-N** NERVE CONDUCTION VELOCITY LOWER LIMBS (復健科) **M29-042-N** F WAVE (復健科) **M29-043-N** H REFLEX (復健科) **M29-033-N** EMG LEG (復健科) **M29-047-N** SNCV, LEG (復健科)	請病房 CR 排程
心肺檢查 CPET		印同意書 打電話給心肺檢查室 7AB (2403-5156)排程

IV laser 靜脈雷射

- 週二到四分別由不同主治醫師執行
  - W2 裴育晟 12:00
  - W3 游東陽 12:00
  - W4 王錦滿 13:30
  - W5 黃書群 11:00, 11:30
- 請於前一天先聯絡當日執行之主治醫師確認治療時間（請避開病人復健時段）
- 告知病人**當天幾點**至 “**經皮靜脈雷射治療室**”(ST room 再往前一點)等待



- 確認病人「有接受 IV laser 後」再開立醫囑單： **S51-993 Intravascular Laser Irradiation**→印出自費同意書→於備註寫上「執行日期」
- 會印出 A5 小單、蓋章、給護理師



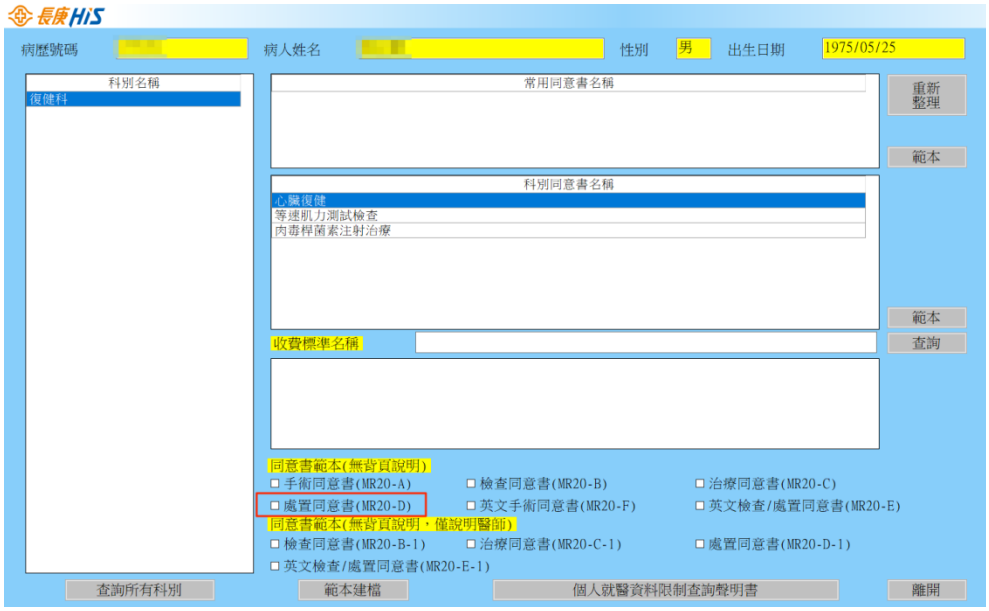
rTMS 重複經顱磁刺激

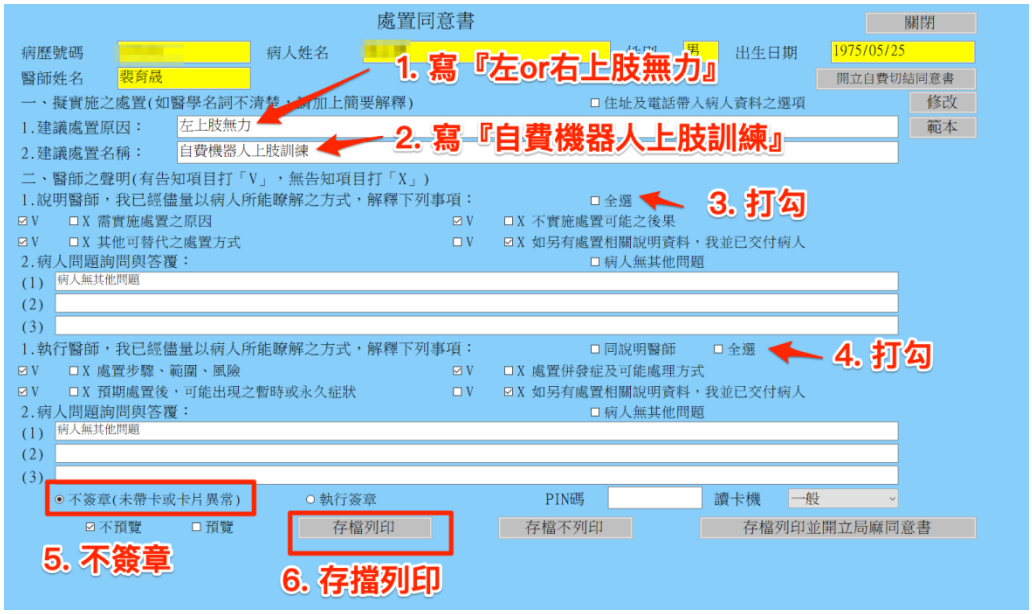
- 若病人想做，請確認無以下禁忌症：
  - 有癲癇病史
  - Brain EEG 有異常腦波
  - 裝有心臟節律器、植入藥物運輸幫浦、人工電子耳、心臟節律器、植入式神經刺激器
  - 頸部以上、腦內有金屬植入物（clip, coil）
  - 顱內動脈瘤或腦損傷
  - 多發性硬化症患者
- 若沒做過 Brain EEG，請先告知主治醫師，經主治醫師同意再幫病人安排
- Order: EEG(AWAKE) M29-021 → 電腦排程
- 以上都 ok，請將病人床號資料告知 R1
- 目前大致治療時段，一次執行約 15 分鐘（經 R1 聯絡主治確認治療時段後，請再轉告知病人）
  - W2　10:30　Dr.鍾維勵
  - W3, W4　10:00　Dr.裴育晟
  - W5　10:30　Dr.黃書群
- 確認時間後，告知病人當天幾點至“大腦調控治療中心”(電梯一出來，往 5H 櫃檯前左手邊)前等候
- **每次做完才開單：M23-280-N**，次數請輸入 2（兩個部位）, 總費用為 4000 元/次。請於備註寫上**「執行日期，共計 2 部位 4000 元，請計價 MA_ _ _ _, XXX」**（該日執行醫師）。並印出 A5 小單、蓋章，交給護理師

機器手

- **開立同意書**：病歷記載 → 同意書 → 同意書開立 → 處置同意書 → 建議處置原因 打『右 or 左上肢肢體功能障礙』→ 建議處置名稱打『自費機器人上肢訓練』→ 二、說明醫師&三、處置醫師旁邊的 □全選 打勾 → 不簽章 → 存擋列印

- 開立 Order：**S51-006：Robotic-assisted Occupational Therapy (Upper Limbs)**，備註寫「自費機器人上肢訓練」。





病房相關規定

- 因病房空間以及病人安全考量，本科陪病以 1 人為限，且需 24 小時陪伴。
- 考量照護、復健連續性需要，盡量不頻繁更換照護者（真有需求，請病人家屬及早提出固定的輪值表，不可以說換就換、說走就走）
- 准假原則：需由主治醫師同意，每次四小時，當日 22:00 前需回病房。一次住院原則以請假 2 次為限，頻繁請假者請跟主治/CR 反應，考慮讓病人及早回家。

COVID 確診如何處理？（參考用，最新感控、藥物規定若有遇到，可再聯繫感控、感染科）

1. 採檢：臨床條件具有下列任一個條件就建議採檢
   A. 發燒(≥38°C)或急性呼吸道感染或嗅、味覺異常。
   B. 臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎。
   C. 無明確旅遊史，醫師高度懷疑之社區型肺炎。
2. 篩完後，開立兩筆 order
   A. Positive:
      I. 轉床隔離單 contact isolation
      II. 家用快篩陽性
   B. Negative:
      I. 解隔條件：主治醫師同意即解隔、快篩陰性 or 確診日 Day 0，Day 5 起可做復健
      II. DC contact isolation
      III. 家用快篩陰性
3. 藥物選擇
   A. 開立抗病毒藥，screen 病人 underlying diseases 和用藥是否符合藥物 indication 並判斷開立哪種藥物適合（paxlovid or molnupiravir)，列印同意書請家屬來簽名，拍照上傳至藥局帳號，即可開立藥物
   B. 重症(有用 O2): Remdesivir*5 days +/- Dexan 6mg/day(注意血糖)
   C. 輕症：能口服就 Paxlovid（注意 DDI）CKD 可 Molnupiravir, 不能口服就 Redesivir

輕症(未使用氧氣)藥物整理(擇一使用)

	Nirmatrelvir+ Ritonavir (Paxlovid) (PO)	Molnupiravir (PO)	Remdesivir (IV)
主要療效	降低89%住院或死亡	降低30%住院或死亡	降低87%住院或死亡
一般劑量	(2# Nirmatrelvir + 1# ritonavir) BID * 5 days	800mg (4#) BID* 5 days	200mg D1, 100mg D2-3
症狀開始	≤ 5 days	≤ 5 days	≤7 days
CKD	- eGFR ≥30 ~ 60: 1# Nirmatrelvir + 1# ritonavir BID *5 days - eGFR <30: Not recommended	No dosage adjustment	- eGFR <30 mL/min: Not recommended
小孩	≥12歲且體重≥40公斤	≥18歲	- ≥12歲且體重≥40公斤: 一般劑量 • <12歲: 5mg/kg IVD D1，2.5mg/kg IVD D2–3
懷孕	No data	Not recommended	效益超越風險的情況下才可投予
哺乳	No data	Not recommended	效益超越風險的情況下才可投予
Cirrhosis (Child C)	Not recommended	No dosage adjustment	ALT >10倍建議停藥
常見副作用	藥物交互作用多, 味覺障礙 (6%), Diarrhea (3%), Hypertension (1%), Myalgia (1%)	Diarrhea(2%), Nausea (1%), Dizziness (1%)	Renal impairment(18%), Hepatic(7%), Glucose increased(11%)

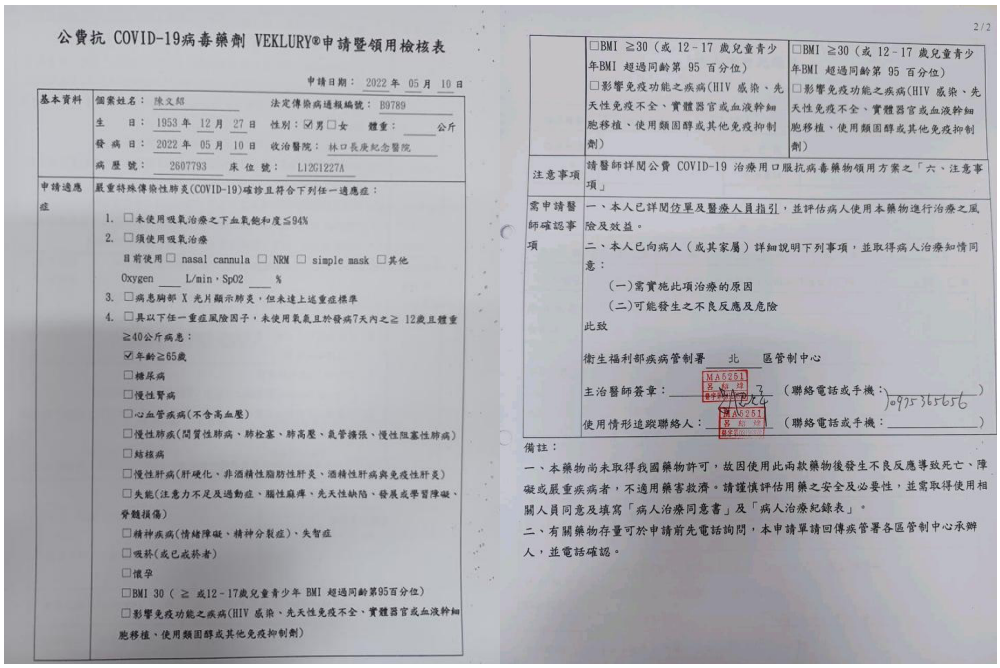
4. 藥物申請

A. Remdesivir

I. Step 1 開藥 (刮號內為 3 日之開立方式)

- UD Remdesivir 6 (or 4) PC once 備註 in N/S 250ml run 1hr
- PREP Remdesivir 2 PC once 備註 in N/S 250ml run 1hr
- PREP Remdesivir 1 PC QD 5(3)day 備註 in N/S 250ml run 1hr on D2-D5(3)
- UD sodium chloride 250ml 6(4) PC once 備註 for Remdesivir

II. Step 2 存檔，系統跳出申請單，填好印出來，幫 vs 簽名蓋章



公費抗 COVID-19病毒藥劑 VEKLURY®申請暨領用檢核表

申請日期：2022 年 05 月 10 日

基本資料
個案姓名：陳文郎　法定傳染病通報編號：B0789
生　日：1953 年 12 月 27 日　性別：☑男☐女　體重：＿＿公斤
發 病 日：2022 年 05 月 10 日　收治醫院：林口長庚紀念醫院
病 歷 號：2607793　床 位 號：LI2G1227A

申請適應症
嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)確診且符合下列任一適應症：
1. ☐未使用吸氧治療之下血氧飽和度≦94%
2. ☐須使用吸氧治療
目前使用 ☐ nasal cannula ☐ NRM ☐ simple mask ☐其他
Oxygen ＿＿ L/min，SpO2 ＿＿ %
3. ☐病患胸部 X 光片顯示肺炎，但未達上述重症標準
4. ☐具以下任一重症風險因子，未使用氧氣且於發病7天內之≧ 12歲且體重≧40公斤病患：
☑年齡≧65歲
☐糖尿病
☐慢性腎病
☐心血管疾病(不含高血壓)
☐慢性肺病(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)
☐結核病
☐慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)
☐失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)
☐精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症
☐吸菸(或已戒菸者)
☐懷孕
☐BMI 30（≧ 或12-17歲兒童青少年 BMI 超過同齡第95百分位）
☐影響免疫功能之疾病(HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植，使用類固醇或其他免疫抑制劑)

☐BMI ≧30（或 12-17 歲兒童青少年BMI 超過同齡第 95 百分位）
☐影響免疫功能之疾病(HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)

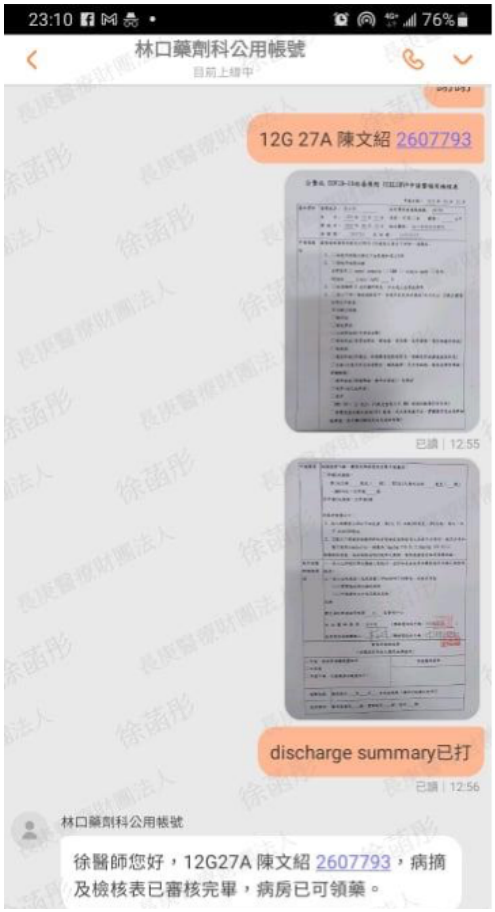
注意事項：請醫師詳閱公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案之「六、注意事項」

需申請醫師確認事項：
一、本人已詳閱仿單及醫療人員指引，並評估病人使用本藥物進行治療之風險及效益。
二、本人已向病人（或其家屬）詳細說明下列事項，並取得病人治療知情同意：
（一）需實施此項治療的原因
（二）可能發生之不良反應及危險
此致
衛生福利部疾病管制署　北　區管制中心
主治醫師簽章：＿＿＿＿（聯絡電話或手機：＿＿＿＿）
使用情形追蹤聯絡人：＿＿＿＿（聯絡電話或手機：＿＿＿＿）

備註：
一、本藥物尚未取得我國藥物許可，故因使用此兩款藥物後發生不良反應導致死亡、障礙或嚴重疾病者，不適用藥害救濟。請謹慎評估用藥之安全及必要性，並需取得使用相關人員同意及填寫「病人治療同意書」及「病人治療紀錄表」。
二、有關藥物存量可於申請前先電話詢問，本申請單請回傳疾管署各區管制中心承辦人，並電話確認。

III. Step 3 打 discharge summary

IV. Step 4 拍照，team pro 傳給「林口藥劑科公用帳號」



B. Paxlovid/ Molnupiravir

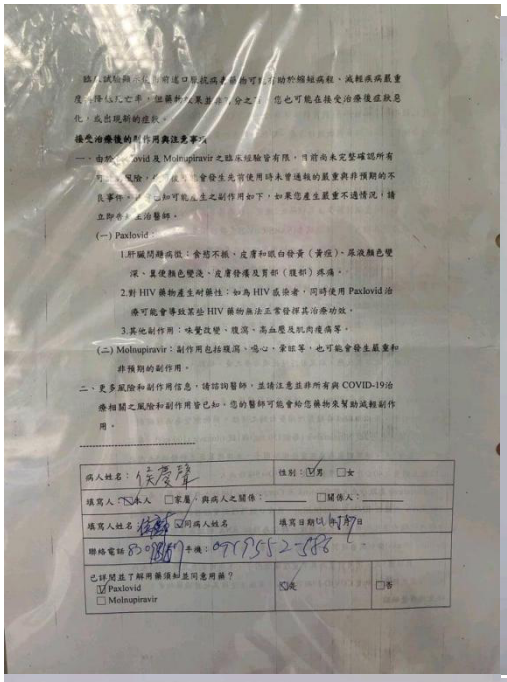




I. Step 1 填「同意書」&「申請單」，同意書請電聯家屬解釋病情後請他們來簽名，簽好後拍照

II. Step 2 拍照，team pro 傳給「林口藥劑科公用帳號」

III. Step 3 藥師回覆訊息後可 開藥 + 領藥



臨床試驗顯示，Paxlovid 可降低病毒量，協助於輕症病程、減輕疾病嚴重度，降低死亡率，但個人效果並不一。之，您也可能在接受治療後症狀惡化，或出現新的症狀。

接受治療後的副作用與注意事項

一、由於 Paxlovid 及 Molnupiravir 之臨床經驗皆有限，可前尚未完整確認所有可能風險，故仍有可能會發生先前使用時未曾通報的嚴重與非預期的不良事件。已知可能產生之副作用如下，如果您產生嚴重不適情況，請立即告知主治醫師。

(一) Paxlovid：

1.肝臟問題病徵：食慾不振、皮膚和眼白發黃（黃疸）、尿液顏色變深、糞便顏色變淺、皮膚發癢及胃部（腹部）疼痛。

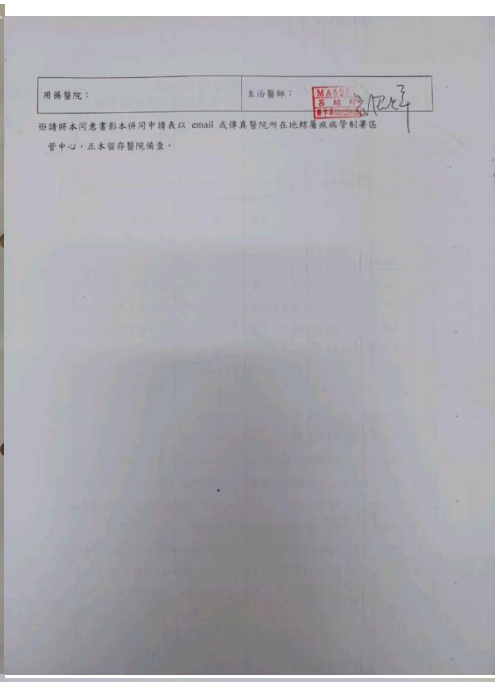
2.對 HIV 藥物產生耐藥性：如為 HIV 感染者，同時使用 Paxlovid 治療可能會導致某些 HIV 藥物無法正常發揮其治療功效。

3.其他副作用：味覺改變、腹瀉、高血壓及肌肉痠痛等。

(二) Molnupiravir：副作用包括腹瀉、噁心、暈眩等，也可能會發生嚴重和非預期的副作用。

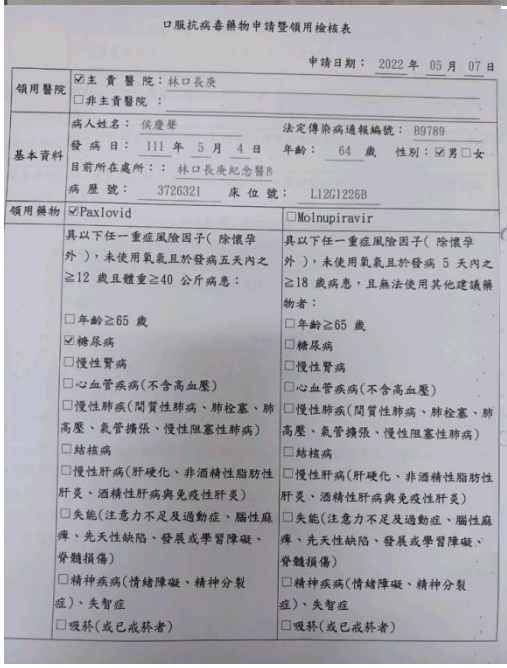
二、更多風險和副作用信息，請諮詢醫師，並請注意並非所有與 COVID-19治療相關之風險和副作用皆已知。您的醫師可能會給您藥物來幫助減輕副作用。

病人姓名：侯慶輝		性別：☑男 ☐女	
填寫人：☐本人 ☐家屬，與病人之關係：＿＿＿ ☐關係人：＿＿＿			
填寫人姓名 侯慶輝 ☑同病人姓名		填寫日期以 111 年 5 月 4 日	
聯絡電話 [illegible] 手機：0919552-188			
已詳閱並了解用藥須知並同意用藥？ ☑Paxlovid ☐Molnupiravir	☑是		☐否



用藥醫院：　　主治醫師：

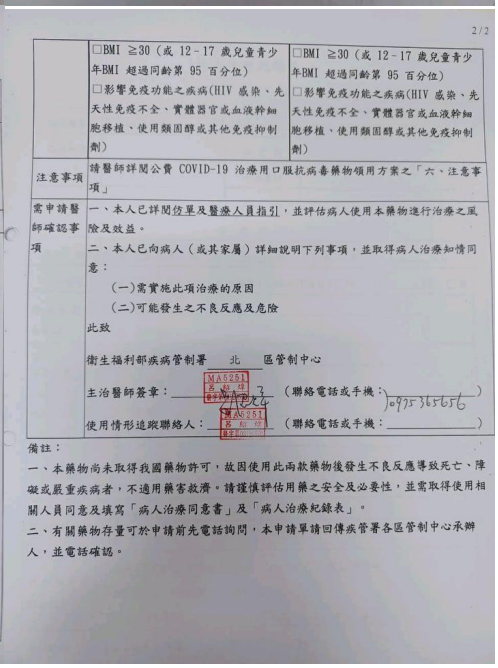
※請將本同意書影本併同申請表以 email 或傳真醫院所在地轄屬疾病管制署區管中心，正本留存醫院備查。



口服抗病毒藥物申請暨領用檢核表

申請日期：2022 年 05 月 07 日

領用醫院	☑主責醫院：林口長庚 ☐非主責醫院：	
基本資料	病人姓名：侯慶輝　法定傳染病通報編號：B9789 發病日：111 年 5 月 4 日　年齡：64 歲　性別：☑男 ☐女 目前所在處所：：林口長庚紀念醫[illegible] 病歷號：3726321　床位號：L12G1226B	
領用藥物	☑Paxlovid	☐Molnupiravir
	具以下任一重症風險因子(除懷孕外)，未使用氧氣且於發病五天內之≧12 歲且體重≧40 公斤病患： ☐年齡≧65 歲 ☑糖尿病 ☐慢性腎病 ☐心血管疾病(不含高血壓) ☐慢性肺疾病(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病) ☐結核病 ☐慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎) ☐失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷) ☐精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症 ☐吸菸(或已戒菸者)	具以下任一重症風險因子(除懷孕外)，未使用氧氣且於發病 5 天內之≧18 歲病患，且無法使用其他建議藥物者： ☐年齡≧65 歲 ☐糖尿病 ☐慢性腎病 ☐心血管疾病(不含高血壓) ☐慢性肺疾病(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病) ☐結核病 ☐慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎) ☐失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷) ☐精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症 ☐吸菸(或已戒菸者)



2/2

	☐BMI ≧30（或 12-17 歲兒童青少年BMI 超過同齡第 95 百分位） ☐影響免疫功能之疾病(HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)	☐BMI ≧30（或 12-17 歲兒童青少年BMI 超過同齡第 95 百分位） ☐影響免疫功能之疾病(HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)
注意事項	請醫師詳閱公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案之「六、注意事項」	
需申請醫師確認事項	一、本人已詳閱仿單及醫療人員指引，並評估病人使用本藥物進行治療之風險及效益。 二、本人已向病人（或其家屬）詳細說明下列事項，並取得病人治療知情同意： (一)需實施此項治療的原因 (二)可能發生之不良反應及危險 此致 衛生福利部疾病管制署 北 區管制中心 主治醫師簽章：＿＿＿＿（聯絡電話或手機：0975365656） 使用情形追蹤聯絡人：＿＿＿＿（聯絡電話或手機：＿＿＿＿）	

備註：

一、本藥物尚未取得我國藥物許可，故因使用此兩款藥物後發生不良反應導致死亡、障礙或嚴重疾病者，不適用藥害救濟。請謹慎評估用藥之安全及必要性，並需取得使用相關人員同意及填寫「病人治療同意書」及「病人治療紀錄表」。

二、有關藥物存量可於申請前先電話詢問，本申請單請回傳疾管署各區管制中心承辦人，並電話確認。